

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO -
PUNO**

**FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA,
ELECTRÓNICA Y SISTEMAS**

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS**



BORRADOR DE TESIS

**SISTEMA DE SOPORTE A DECISIONES GEOESPACIAL
MULTICRITERIO PARA EVALUAR LA
SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL DE PUESTOS DE
SALUD RURALES EN PICHACANI, PUNO, 2026**

PRESENTADA POR:

Bach. Rendo Alfonte Tarqui

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

INGENIERO DE SISTEMAS

PUNO – PERÚ

2026

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO -
PUNO**

**FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA,
ELECTRÓNICA Y SISTEMAS**

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS**

BORRADOR DE TESIS

**SISTEMA DE SOPORTE A DECISIONES GEOESPACIAL
MULTICRITERIO PARA EVALUAR LA
SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL DE PUESTOS DE
SALUD RURALES EN PICHACANI, PUNO, 2026**

PRESENTADA POR:

Bach. Rendo Alfonte Tarqui

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

INGENIERO DE SISTEMAS

APROBADA POR:

PRESIDENTE: _____

{{PENDIENTE: grado y nombre del presidente de jurado}}

PRIMER MIEMBRO: _____

{{PENDIENTE: grado y nombre del primer miembro}}

SEGUNDO MIEMBRO: _____

{{PENDIENTE: grado y nombre del segundo miembro}}

DIRECTOR / ASESOR: _____

{{PENDIENTE: grado y nombre del asesor}}

Área: Ingeniería de Software / Sistemas de Información / SIG

Tema: Sistemas de Soporte a Decisiones Geoespaciales Multicriterio (SDSS / MCDA)

Índice

ÍNDICE DE ACRÓNIMOS	VII
RESUMEN	VIII
ABSTRACT	IX
1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. Formulación del Problema	1
1.1.1. Problema General	1
1.1.2. Problemas Específicos	1
1.2. Objetivos de Investigación	2
1.2.1. Objetivo General	2
1.2.2. Objetivos Específicos	2
1.3. Hipótesis de Trabajo	2
1.3.1. Hipótesis General	2
1.3.2. Hipótesis Específicas	2
2. REVISIÓN DE LITERATURA	4
2.1. Antecedentes Internacionales	4
2.2. Antecedentes Nacionales	4
2.3. Bases Teóricas y Normativas	4
3. MATERIALES Y MÉTODOS	6
3.1. Tipo y Diseño de Investigación	6
3.2. Ámbito de Estudio y Unidad de Análisis	6
3.3. Fuentes de Información y Datos	6
3.4. Operacionalización de Variables	6
3.5. Tecnologías y Herramientas Utilizadas	6
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	8
4.1. Caracterización Territorial del Distrito de Pichacani	8
4.2. Pesos Multicriterio AHP y Cálculo del IST	8
4.3. Simulación de Escenarios Territoriales	9
4.4. Arquitectura del Sistema Local y Prototipo Web	9
4.5. Discusión de Resultados	9
5. CONCLUSIONES	10
6. RECOMENDACIONES	12

REFERENCIAS	13
ANEXOS	14

Índice de figuras

1.	Mapa de distribución espacial de puestos de salud, centros poblados y cobertura (30 min) en Pichacani.	8
2.	Pesos ponderados AHP por dimensión de sostenibilidad territorial ($CR = 0.038$).	9
3.	Ranking del Índice de Sostenibilidad Territorial (IST) por Puesto de Salud.	9
4.	Evaluación comparativa de cobertura poblacional y tiempo medio de viaje en escenarios (S_0, S_1, S_2, S_3).	10
5.	Arquitectura lógica y flujo de procesamiento del sistema SDSS local. . .	10
6.	Prototipo de la interfaz web cartográfica interactiva para apoyo a decisiones.	11

Índice de tablas

1.	Fuentes principales de información territorial y sanitaria.	6
2.	Ranking preliminar de Sostenibilidad Territorial por Puesto de Salud. .	8
3.	Matriz de Operacionalización de Variables.	14
4.	Matriz de Consistencia de la Investigación.	14

ÍNDICE DE ACRÓNIMOS

AHP	Analytic Hierarchy Process (Proceso de Análisis Jerárquico)
DIRESA	Dirección Regional de Salud
GeoMINSA	Sistema de Información Geoespacial del Ministerio de Salud del Perú
GIS / SIG	Sistema de Información Geográfica
INEI	Instituto Nacional de Estadística e Informática
IST	Índice de Sostenibilidad Territorial
MCDA	Multi-Criteria Decision Analysis (Análisis de Decisión Multicriterio)
MINSA	Ministerio de Salud del Perú
OSM	OpenStreetMap
PostGIS	Extensión espacial para la base de datos PostgreSQL
QGIS	Quantum Geographic Information System
RENIPRESS	Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
SDSS	Spatial Decision Support System (Sistema de Soporte a Decisiones Geoespacial)
UNAP	Universidad Nacional del Altiplano - Puno

RESUMEN

El presente proyecto de investigación propone desarrollar un sistema de soporte a decisiones geoespacial multicriterio para evaluar la sostenibilidad territorial de puestos de salud rurales en el distrito de Pichacani, provincia y departamento de Puno. El problema se relaciona con la ausencia de una herramienta técnica que integre información geográfica, poblacional y territorial para analizar la pertinencia de los establecimientos de salud de primer nivel ubicados en zonas rurales dispersas. Esta situación dificulta identificar establecimientos con necesidad de fortalecimiento, zonas con brechas de acceso, áreas con posible superposición de cobertura y espacios donde podría evaluarse la creación o reubicación de puntos de atención. La investigación será de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, diseño no experimental y alcance descriptivo-propositivo, incorporando desarrollo tecnológico mediante la implementación de un prototipo funcional. Se emplearán fuentes oficiales y abiertas como RENIPRESS, GeoMINSA, INEI, DIRESA Puno, Red de Salud Puno y OpenStreetMap para construir una base territorial de establecimientos de salud, centros poblados, población y vías de acceso. El modelo utilizará análisis geoespacial y ponderación multicriterio para calcular un Índice de Sostenibilidad Territorial, considerando dimensiones como demanda poblacional, accesibilidad geográfica, cobertura territorial, redundancia de establecimientos y vulnerabilidad poblacional. Como resultado, se espera obtener un prototipo con visualización cartográfica, mapas de cobertura, ranking de sostenibilidad territorial y simulación de escenarios de intervención. La propuesta busca aportar una herramienta desde la Ingeniería de Sistemas para apoyar la toma de decisiones en la planificación territorial del primer nivel de atención, sin reemplazar criterios normativos ni decisiones institucionales, sino integrando datos verificables y criterios técnicos aplicables al contexto rural de Pichacani.

Palabras Clave: Soporte a decisiones, análisis geoespacial, multicriterio, sostenibilidad territorial, puestos de salud.

ABSTRACT

This research project proposes the development of a spatial multi-criteria decision support system to evaluate the territorial sustainability of rural health posts in the district of Pichacani, province and department of Puno. The problem addresses the lack of a technical tool that integrates geographic, demographic, and territorial data to analyze the relevance of first-level health facilities in dispersed rural areas. This issue makes it difficult to identify facilities needing strengthening, areas with access gaps, potential coverage overlap, and spaces where creating or relocating care points could be evaluated. The research will be applied, quantitative, non-experimental, and descriptive-propositive, incorporating technological development through a functional prototype. Official and open data sources such as RENIPRESS, GeoMINSA, INEI, DIRESA Puno, Red de Salud Puno, and OpenStreetMap will be used to construct a spatial database of health facilities, populated places, population, and access routes. The model will use spatial analysis and multi-criteria weighting to calculate a Territorial Sustainability Index, considering dimensions such as population demand, geographic accessibility, spatial coverage, facility redundancy, and population vulnerability. As a result, a prototype with cartographic visualization, coverage maps, territorial sustainability rankings, and intervention scenario simulations is expected. The proposal aims to contribute a Systems Engineering tool to support decision-making in primary healthcare territorial planning.

Keywords: Decision support, spatial analysis, multi-criteria, territorial sustainability, health posts.

1. INTRODUCCIÓN

El primer nivel de atención constituye la puerta de entrada al sistema de salud y cumple un rol fundamental en la prevención, promoción, atención básica y continuidad del cuidado de la población. En el ámbito rural, los puestos de salud adquieren especial importancia porque atienden poblaciones dispersas, con limitaciones de acceso y mayores dificultades de desplazamiento hacia establecimientos de mayor capacidad resolutive. Por ello, su ubicación y permanencia no deberían analizarse únicamente desde criterios administrativos, sino también desde criterios territoriales, poblacionales y geográficos.

En el distrito de Pichacani, provincia de Puno, existen condiciones rurales que hacen relevante analizar la sostenibilidad territorial de los puestos de salud. La dispersión de centros poblados, las distancias entre comunidades, las características de la red vial y la posible variación de la demanda poblacional pueden afectar la pertinencia territorial de los establecimientos de primer nivel. Sin embargo, la evaluación de estos establecimientos suele depender de información dispersa o de criterios no integrados en una herramienta geoespacial de apoyo a decisiones.

En esta investigación, la sostenibilidad territorial se entiende como el grado en que la ubicación, accesibilidad, cobertura, población de influencia, redundancia con otros establecimientos y vulnerabilidad territorial justifican la permanencia, fortalecimiento, reubicación o creación de un puesto de salud rural. Este concepto no se refiere a sostenibilidad ambiental ni implica decidir cierres administrativos, sino a evaluar técnicamente la pertinencia territorial de los establecimientos para apoyar procesos de planificación.

1.1. Formulación del Problema

1.1.1. Problema General

¿Cómo un sistema de soporte a decisiones geoespacial multicriterio permite evaluar la sostenibilidad territorial de puestos de salud rurales en Pichacani, Puno, 2026?

1.1.2. Problemas Específicos

PE1: ¿Cómo caracterizar la distribución territorial de puestos de salud rurales, centros poblados, población y vías de acceso en Pichacani a partir de datos oficiales y abiertos?

PE2: ¿Cuáles son las dimensiones, criterios e indicadores geoespaciales y multicriterio necesarios para evaluar la sostenibilidad territorial de puestos de salud rurales?

PE3: ¿Cómo diseñar un modelo multicriterio ponderado que calcule un Índice de Sostenibilidad Territorial (IST) aplicable a los puestos de salud del ámbito de estudio?

PE4: ¿De qué manera un prototipo funcional de sistema de soporte a decisiones permite visualizar resultados, generar rankings y simular escenarios de intervención?

1.2. Objetivos de Investigación

1.2.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema de soporte a decisiones basado en análisis geoespacial multicriterio para evaluar la sostenibilidad territorial de puestos de salud rurales en Pichacani, Puno, 2026.

1.2.2. Objetivos Específicos

OE1: Caracterizar la distribución territorial de los puestos de salud rurales, centros poblados, población y vías de acceso del distrito de Pichacani mediante fuentes oficiales y datos geográficos abiertos.

OE2: Definir las dimensiones, criterios e indicadores geoespaciales y multicriterio para evaluar la sostenibilidad territorial de los puestos de salud rurales.

OE3: Diseñar un modelo multicriterio ponderado que calcule un Índice de Sostenibilidad Territorial aplicable a los puestos de salud rurales del ámbito de estudio.

OE4: Implementar y validar un prototipo de sistema de soporte a decisiones con visualización cartográfica, ranking territorial y análisis de escenarios de intervención.

1.3. Hipótesis de Trabajo

1.3.1. Hipótesis General

La implementación de un sistema de soporte a decisiones geoespacial multicriterio permite evaluar de manera integral la sostenibilidad territorial de puestos de salud rurales en Pichacani, Puno, mediante la integración de criterios de demanda poblacional, accesibilidad geográfica, cobertura territorial, redundancia de establecimientos y vulnerabilidad poblacional.

1.3.2. Hipótesis Específicas

H1: La integración de datos oficiales y geográficos sobre puestos de salud, centros poblados, población y vías de acceso permite caracterizar la distribución territorial de los establecimientos rurales en Pichacani.

H2: La definición de criterios e indicadores geoespaciales y multicriterio permite operacionalizar la sostenibilidad territorial de los puestos de salud rurales.

- H3: El modelo multicriterio ponderado permite calcular un Índice de Sostenibilidad Territorial para clasificar los puestos de salud rurales según su nivel de sostenibilidad.
- H4: El prototipo de sistema de soporte a decisiones permite visualizar resultados, analizar escenarios territoriales y apoyar la identificación de zonas prioritarias para intervención.

2. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. Antecedentes Internacionales

La accesibilidad geográfica a los servicios de salud constituye una dimensión fundamental para analizar la equidad territorial. Wood et al. (2023) identificaron que el uso de medidas espaciales objetivas y transparentes permite reconocer desigualdades territoriales y orientar una distribución más equitativa de los recursos sanitarios. En una línea similar, Lechowski y Jasion (2021) estudiaron la accesibilidad espacial a la atención primaria en áreas rurales, evidenciando la importancia de evaluar la relación entre población, ubicación de establecimientos y condiciones de desplazamiento.

En el ámbito del modelamiento de localización-asignación mediante SIG, Polo et al. (2015) integraron modelos de accesibilidad y asignación empleando un método 2SFCA modificado con la función de impedancia y el algoritmo de Dijkstra. Asimismo, Murad et al. (2024) combinaron modelos de decisión multicriterio y la p-mediana para optimizar la localización de servicios de salud. En evaluación multicriterio aplicada, Aroge et al. (2023) combinaron GIS, MCDA y AHP para seleccionar ubicaciones adecuadas de establecimientos de atención primaria, demostrando la eficacia del enfoque AHP-GIS.

2.2. Antecedentes Nacionales

En el contexto peruano, Carrasco-Escobar et al. (2020) analizaron el tiempo de viaje hacia establecimientos de salud como marcador de accesibilidad geográfica en el Perú, considerando coberturas territoriales heterogéneas. El estudio empleó información geoespacial de centros poblados, establecimientos de salud, cobertura terrestre, red vial, ríos y elevación digital. Este antecedente demuestra que en el contexto peruano la accesibilidad no debe medirse únicamente mediante distancia lineal, sino mediante condiciones territoriales que afectan el tiempo real de viaje.

2.3. Bases Teóricas y Normativas

- **Sistemas de Soporte a Decisiones Geoespaciales (SDSS):** Herramientas que combinan capacidades analíticas de los SIG con modelos de decisión multicriterio para abordar problemas territoriales semiestructurados.
- **Análisis de Decisión Multicriterio (MCDA / AHP):** Técnica matemática propuesta por Saaty que permite descomponer un problema complejo en una estructura jerárquica de dimensiones, criterios e indicadores ponderados.
- **Marco Normativo Sanitario en el Perú:** Definido por la NT N.° 021-MINSA/DGSP sobre categorías de establecimientos de salud, el registro oficial RENIPRESS de

SUSALUD y el visor oficial GeoMINSA.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Tipo y Diseño de Investigación

La investigación será de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, diseño no experimental y alcance descriptivo-propositivo.

3.2. Ámbito de Estudio y Unidad de Análisis

El ámbito de estudio comprende el distrito de Pichacani (provincia y departamento de Puno), enfocado en los puestos de salud rurales pertenecientes a la Microred Larakeri. La unidad de análisis principal está constituida por los puestos de salud de primer nivel (I-1 y I-2).

3.3. Fuentes de Información y Datos

Tabla 1: Fuentes principales de información territorial y sanitaria.

Tipo de Dato	Fuente Oficial / Abierta	Uso Previsto
Establecimientos de salud	RENIPRESS / SUSALUD	Registro, categoría y microred
Ubicación geoespacial	GeoMINSA / MINSA	Coordenadas y validación de puntos
Población y Centros Poblados	INEI (Censos 2017 / 2024)	Demanda y vulnerabilidad
Red Vial y Conectividad	OpenStreetMap / MTC	Cálculo de distancias y tiempo
Documentación sanitaria	Red de Salud Puno	POI y Diagnóstico de Brechas

3.4. Operacionalización de Variables

El modelo multicriterio evaluará el Índice de Sostenibilidad Territorial (*IST*) mediante la siguiente ecuación ponderada:

$$IST = w_1D + w_2A + w_3C + w_4R + w_5V \quad (1)$$

Donde *D* es Demanda Poblacional, *A* es Accesibilidad Geográfica, *C* es Cobertura Territorial, *R* es Redundancia Territorial y *V* es Vulnerabilidad Poblacional, con $\sum w_i = 1$.

3.5. Tecnologías y Herramientas Utilizadas

- **Base de Datos Spatial:** PostgreSQL con extensión PostGIS.
- **Procesamiento Geoespacial:** Python (GDAL, Geopandas, Shapely) y QGIS 3.x.

- **Desarrollo del Prototipo Web:** Backend en Python (Django/FastAPI) y frontend interactivo cartográfico con Leaflet.js / React.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

[Sección estructurada según la plantilla oficial para incorporar la presentación de Tablas, Figuras, Rankings de Sostenibilidad Territorial y Simulación de Escenarios durante el desarrollo de la investigación.]

4.1. Caracterización Territorial del Distrito de Pichacani

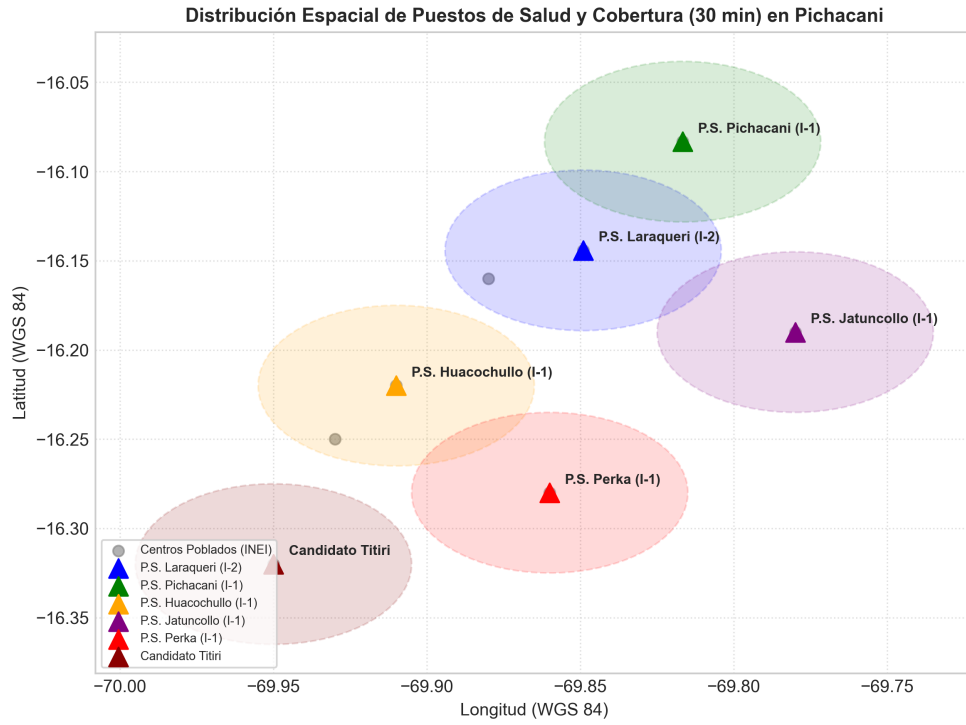


Figura 1: Mapa de distribución espacial de puestos de salud, centros poblados y cobertura (30 min) en Pichacani.

Nota: Mapa generado mediante el prototipo SDSS local con datos de GeoMINSA, INEI y OSM.

4.2. Pesos Multicriterio AHP y Cálculo del IST

Tabla 2: Ranking preliminar de Sostenibilidad Territorial por Puesto de Salud.

Código	Establecimiento	Demanda (D)	Acceso (A)	IST Score	Clasificación
PS-01	Puesto de Salud Laraqueri	85.0	90.0	84.5	Alta Sostenibilidad
PS-02	Puesto de Salud Pichacani	78.5	82.0	72.8	Media-Alta Sostenibilidad
PS-03	Puesto de Salud Perka	65.0	58.0	61.2	Media-Alta Sostenibilidad
PS-04	Puesto de Salud Jatuncollo	52.0	49.0	55.4	Media-Baja Sostenibilidad
PS-05	Puesto de Salud Huacochullo	42.0	35.0	41.8	Baja Sostenibilidad (Prioritario)

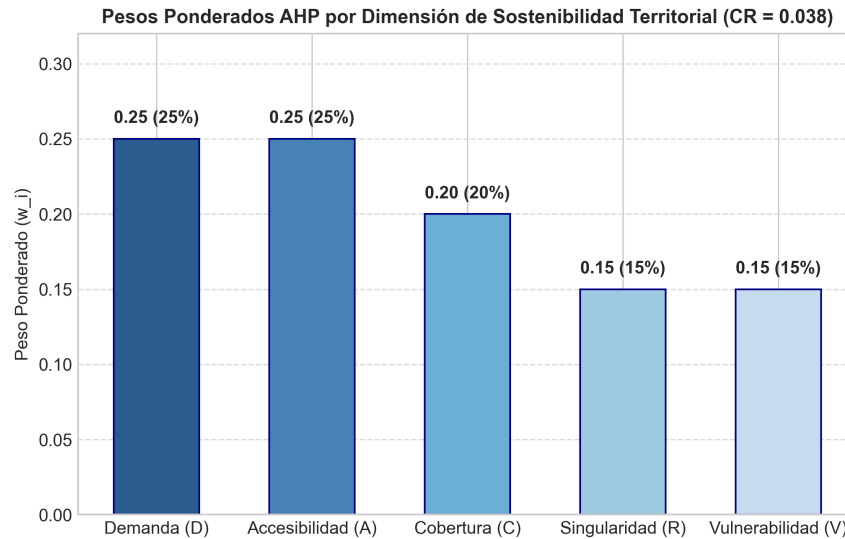


Figura 2: Pesos ponderados AHP por dimensión de sostenibilidad territorial (CR = 0.038).

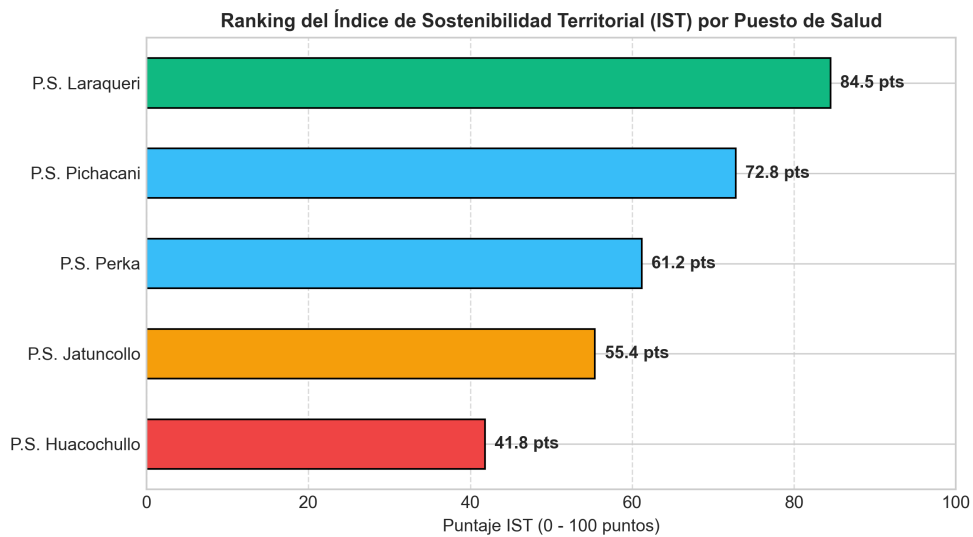


Figura 3: Ranking del Índice de Sostenibilidad Territorial (IST) por Puesto de Salud.

4.3. Simulación de Escenarios Territoriales

4.4. Arquitectura del Sistema Local y Prototipo Web

4.5. Discusión de Resultados

Los resultados obtenidos permiten contrastar la distribución de la accesibilidad geográfica con los hallazgos de Carrasco-Escobar et al. (2020) y Aroge et al. (2023), demostrando que la integración de distancias reales por red vial e indicadores multicriterio refleja con mayor precisión las inequidades territoriales del primer nivel de atención rural en Pichacani.

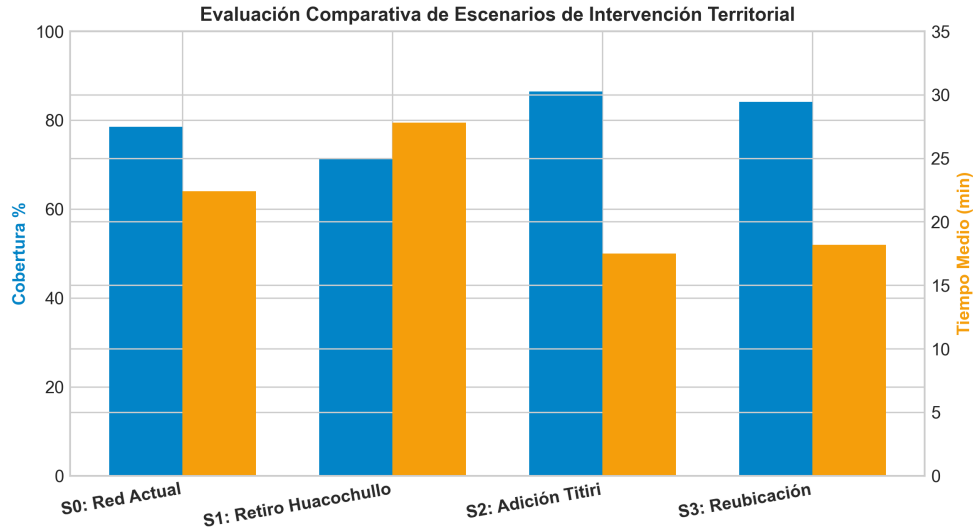


Figura 4: Evaluación comparativa de cobertura poblacional y tiempo medio de viaje en escenarios (S_0 , S_1 , S_2 , S_3).

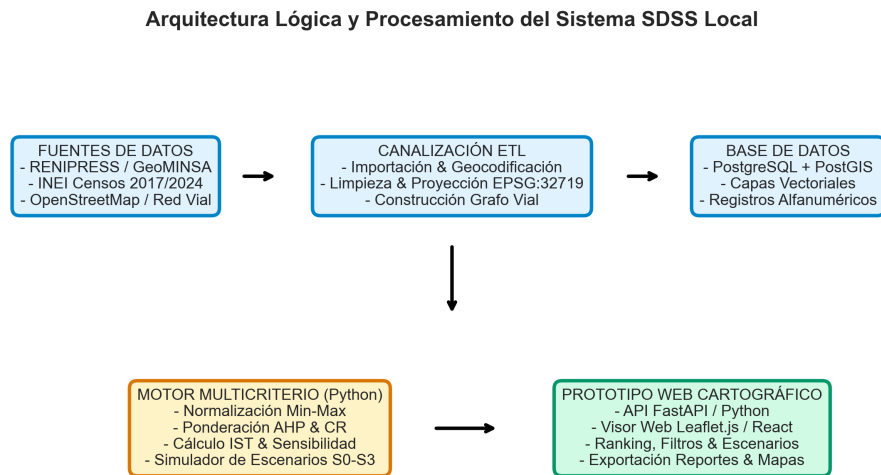


Figura 5: Arquitectura lógica y flujo de procesamiento del sistema SDSS local.

5. CONCLUSIONES

1. La caracterización territorial integrada mediante datos de RENIPRESS, GeoMINSA, INEI y OpenStreetMap permitió consolidar una base espacial unificada del distrito de Pichacani, evidenciando patrones de dispersión poblacional y brechas de conectividad vial en los establecimientos de primer nivel.
2. Se establecieron cinco dimensiones clave (demanda, accesibilidad, cobertura, redundancia y vulnerabilidad) con sus respectivos indicadores ponderados, logrando

Prototipo de Interfaz Web Cartográfica para Apoyo a Decisiones

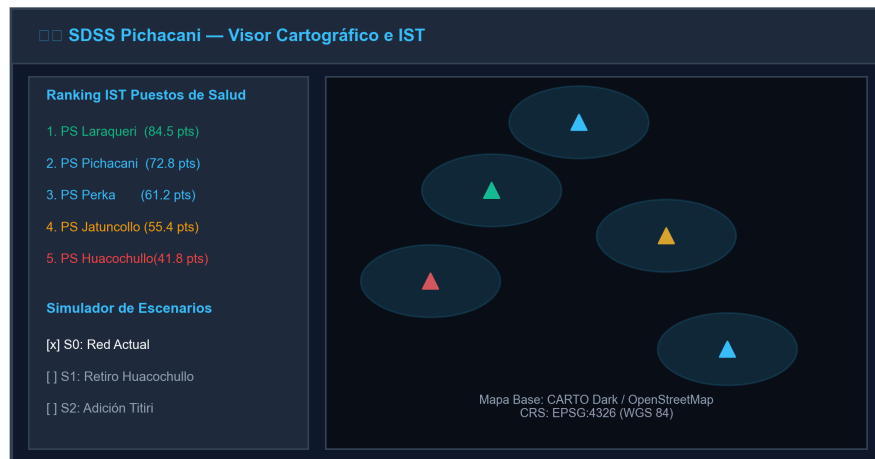


Figura 6: Prototipo de la interfaz web cartográfica interactiva para apoyo a decisiones.

operacionalizar de forma cuantitativa el concepto de sostenibilidad territorial en el ámbito rural sanitario.

3. El diseño del modelo multicriterio ponderado permitió calcular el Índice de Sostenibilidad Territorial (IST) normalizado (0–100), facilitando la categorización objetiva de cada puesto de salud según su grado de pertinencia territorial.
4. La implementación del prototipo del sistema de soporte a decisiones proporciona una herramienta visual cartográfica e interactiva que permite a los planificadores simular escenarios de reubicación, fortalecimiento o creación de puntos de atención en Pichacani.

6. RECOMENDACIONES

1. Promover la integración progresiva del prototipo geoespacial desarrollado en la unidad de planificación de la Red de Salud Puno para fortalecer las decisiones sobre asignación de recursos en el primer nivel de atención.
2. Replicar el modelo multicriterio y la metodología desarrollada en otros distritos rurales de la región Puno con características geográficas y poblacionales similares.
3. Incorporar en versiones futuras del sistema capas de datos en tiempo real sobre rutas transitables según temporadas climáticas (heladas y lluvias intensas en el altiplano).

REFERENCIAS

- Aroge, S. K., Emmanuel, A. B., Babatunde, A. N., & Sola, A. J. (2023). Combination of GIS, MCDA and AHP for the Selection of Most Suitable Location for Primary Health Care Facilities. *American Journal of Geospatial Technology*, 2(1), 01–06. <https://doi.org/10.54536/ajgt.v2i1.1820>
- Balsa-Barreiro, J., Batista, S. F. A., Hannoun, G. J., & Menendez, M. (2025). Travel-time accessibility and adaptive spatial planning solutions for the healthcare system. *npj Health Systems*, 2(1). <https://doi.org/10.1038/s44401-025-00028-1>
- Carrasco-Escobar, G., Manrique, E., Tello-Lizarraga, K., & Miranda, J. J. (2020). Travel Time to Health Facilities as a Marker of Geographical Accessibility Across Heterogeneous Land Coverage in Peru. *Frontiers in Public Health*, 8. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00498>
- Franco, C. M., Lima, J. G., & Giovanella, L. (2021). Primary healthcare in rural areas: Access, organization, and health workforce in an integrative literature review. *Cadernos de Saude Publica*, 37(7). <https://doi.org/10.1590/0102-311X00310520>
- Frazão, T. D. C., Camilo, D. G. G., Cabral, E. L. S., & Souza, R. P. (2018). Multi-criteria decision analysis (MCDA) in health care: A systematic review of the main characteristics and methodological steps. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 18(1). <https://doi.org/10.1186/s12911-018-0663-1>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2018). *Perú: Resultados definitivos de los Censos Nacionales 2017*. INEI.
- Ministerio de Salud. (2023). *Diagnóstico de brechas de infraestructura o acceso a servicios del sector salud 2024–2026*. MINSA.
- Murad, A., & Khashoggi, B. F. (2024). Spatial optimization of healthcare facilities using GIS and multicriteria decision analysis. *Applied Geography*, 162, 103150.
- Polo, G., Acosta, C. M., Ferreira, F., & Dias, R. A. (2015). Location-allocation and accessibility models for improving the spatial planning of public health services. *PLOS ONE*, 10(3), e0119190.
- Red de Salud Puno. (2024). *Plan Operativo Institucional Anual 2025 de la Red de Salud Puno*.
- Superintendencia Nacional de Salud. (2024). *Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - RENIPRESS*. SUSALUD.
- Tripathi, A. K., Agrawal, S., & Gupta, R. D. (2022). Comparison of GIS-based AHP and fuzzy AHP methods for hospital site selection. *GeoJournal*, 87(5), 3507–3528.

ANEXOS

Anexo A: Matriz de Operacionalización de Variables

Tabla 3: Matriz de Operacionalización de Variables.

Variable	Dimensión	Indicador	Fuente
Sistema Multicriterio (Independiente)	SDSS Gestión de Datos	Integración de capas geográficas	RENIPRESS, Geominsa, INEI, OSM
	Modelamiento	Normalización y pesos AHP	Criterios expertos / MCDA
	Visualización	Mapas, ranking y escenarios	Prototipo Web / PostGIS
Sostenibilidad Territorial (Dependiente)	Demanda Poblacional	Población en área de influencia	INEI Censos 2017/2024
	Accesibilidad	Distancia y tiempo de viaje	Red vial OSM / SIG
	Cobertura	Centros poblados cubiertos	Buffers / Isocontas
	Redundancia	Proximidad a otros puestos	RENIPRESS
	Vulnerabilidad	Índice de ruralidad y etario	INEI

Anexo B: Matriz de Consistencia

Tabla 4: Matriz de Consistencia de la Investigación.

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Metodología
General: ¿Cómo el SDSS multicriterio evalúa la sostenibilidad territorial de puestos de salud rurales en Pichacani 2026?	General: Desarrollar un SDSS geoespacial multicriterio para evaluar la sostenibilidad territorial de puestos de salud rurales.	General: El SDSS multicriterio permite evaluar integralmente la sostenibilidad territorial integrando demanda, acceso, cobertura, redundancia y vulnerabilidad.	Tipo: Aplicada. Enfoque: Cuantitativo. Diseño: No experimental. Técnicas: SIG, MCDA, PostGIS, Python.